

KC桌面——外资精译

美洲医疗保健：生物技术——与内分泌科医生午餐会关于关键产品上市及近期数据的要点总结

我们与成人内分泌科医生Aren Skolnick博士（每月接诊约350名患者）共进午餐，讨论了广泛的内分泌疾病，包括：甲状旁腺功能减退症、先天性肾上腺皮质增生症、减重术后低血糖、普拉德-威利综合征、下丘脑性肥胖、软骨发育不全、肢端肥大症以及格雷夫斯病/甲状腺眼病。在各类适应症中，该医生在少数患者中使用了新型疗法，并指出尽管存在保险/报销方面的障碍（他提到这是其诊所在处理高价位罕见病疗法时普遍面临的问题，通常需要制造商的大力支持），但迄今为止对Yorvipath、Crenessity和Vykat的使用体验良好。关于在研候选药物，该医生认为：i)

atumelnant在CAH治疗中可能通过便利性/作用机制实现差异化（尤其适用于Crenessity控制不佳的患者）；ii)

近期setmelanotide在PWS中的数据在减重方面前所未有，且在生活质量终点上令人信服；iii)

PBH领域存在巨大未满足需求，avexitide或可满足（以L2/L3事件绝对降低50%作为临床意义的基准）；iv)

canvuparatide显示出令人鼓舞的临床活性证据，并指出临床试验中的应答者分析并未反映真实世界的治疗实践。

详情请见下文。

关键点

甲状旁腺功能减退症 (ASND, MBX)

每周给药更受欢迎，但真实世界的采用取决于全面的数据概况。

该KOL在其诊所管理约10名HPT患者，其中一半患者控制良好，五名患者目前正在接受Yorvipath治疗。

医生指出，已升级使用Yorvipath的患者并不介意每日注射频率，总体上对逐渐减少补充剂并仍能维持血钙水平感到满意。

■ Yorvipath最初用于病情严重且控制不佳的患者（经常发生低钙血症事件/肾脏问题）或住院患者，现在正逐步用于中度控制人群。

KOL认为每周注射剂的应答率门槛为50%。

关于近期MBX每周一次canvuparatide的52周数据更新显示，应答率从26周的79%下降至57%（见注释），KOL指出Yorvipath在治疗方面仍是金标准（回顾：Yorvipath Ph3数据显示在26-52周内疗效稳定在约80%）。然而，KOL认为50%的应答率是每周注射剂可接受的权衡阈值，并指出临床研究中限制PRN使用的应答标准并未反映真实世界的治疗实践，因此应在整体临床获益的背景下进行评估。

\- Canvuparatide最有可能吸引那些每日给药稳定且希望降低给药频率的患者。此外，他可能会为那些否则无法耐受每日注射的新患者启用该药。未来，他希望监测长期随访中疗效是否持续。

\- 在定价方面，KOL认为canvuparatide可以溢价定价，但预计会面临一些支付方障碍。

先天性肾上腺皮质增生症 (NBIX, CRNX)

Crenessity使用体验积极，atumelnant可能通过差异化作用机制满足未满足需求

我们的专家正在治疗约20名CAH患者，并已在其三名女性患者中使用Crenessity以更好地控制高雄激素水平。迄今为止，使用受到患者症状负担（包括库欣样症状）的限制，而一些患者并非经典CAH，另一些患者自Crenessity上市后尚未就诊（标准为每年1-2次就诊）。使用Crenessity的三名患者能够降低GC用量，同时实现更低的体重和血糖水平。报销问题可控，NBIX在帮助处理文档和事先授权要求方面提供了帮助，支付方批准患者使用Cren

essity通常只需3-4周。

医生认为近期Crenessity对骨骼影响的两年更新数据很有用，因为年轻患者仍在积累峰值骨量，这可以进一步支持在这些患者中的使用。心脏代谢获益已在预期之中。然而，医生指出，Crenessity每日两次的给药要求以及对雄激素缺乏影响（观察到的是稳定而非降低）是该药物的局限性。这些缺点可能会促使专家在atumelnant获批后使用它，因为其每日一次口服给药，并且基于其差异化的MC2R拮抗剂机制，有可能将A4水平降至正常上限以下，尤其适用于初治患者以及使用Crenessity后仍有症状或控制不佳的患者。专家提到，他使用Crenessity的三名患者中有两名可能受益于换用atumelnant，但他承认这只是小样本量。

■ 关于此前在atumelnant中观察到的肝脏毒性发现，医生并不担心，因为发生率低且病例似乎较轻。然而，如果未来结果显示LFT水平超过正常上限3倍，这可能会引起担忧。

减重术后低血糖 (AMLX)

PBH人群存在巨大未满足需求，估计占患者的15-20%，反映在患者对新治疗选择的需求上

医生将这一人群描述为未满足需求非常高的群体，并指出在他的诊所中，患者寻求新的、更好的治疗方案以及对当前标准治疗感到沮丧的参与度是最高的之一。他指出，像二氮嗪这样的标准治疗方案效果不佳，并带来显著的生活质量负担；虽然他尝试过GLP-1激动剂（基于延缓胃排空），但这些药物效果并不特别好，相当一部分患者需要新的选择。

\- 在他接诊的约30名患者中，医生指出约40%的患者通过饮食调整或现有疗法控制不佳，至少15-20%的患者经常发生严重的低血糖事件。后者将是avexitide获批后启动治疗的最明确候选人群，我们注意到这与我们自己的估计高度一致，即约3万名患者将构成初始可及市场（相对于16万的患者患病率）。

在Ph3数据公布之前，KOL指出，在疗效方面，L2/L3事件绝对降低50%将具有说服力，这与试验设计假设的安慰剂校正改善35%以及预期的约50%安慰剂应答率形成对比。

虽然医生认为，如果avexitide获批用于PBH，保险覆盖可能需要文件证明，但他并不认为这是治疗推广的重大障碍，并指出将PBH与其他形式的低血糖症进行分类已是标准做法。

除PBH外，该KOL认为使用avexitide或其他GLP-1拮抗剂治疗其他形式的低血糖症也具有一定前景。

普拉德-威利综合征 (NBIX, CRNX, RYTM)

对这一极难治疗的患者群体，Vykat和setmelanotide均获热情评价

该医生目前正在少数患者中使用Vykat，并计划向其更广泛的患者群体告知这一新选择。他指出，迄今为止的经验表明，患者尤其是照护者的生活质量有所改善。后者对他而言尤为重要，并将影响未来扩大使用该药物的计划。在安全性方面，虽然医生正在监测水肿/高血糖，并可能限制有这些风险的患者用药，但迄今为止尚未观察到显著副作用。保险报销是治疗推广的一个中等障碍。

■ 关于RYTM在PWS方面的近期数据，医生评论称，相对于这一难治且高度代谢抵抗的人群，减重效果前所未有的，并指出GLP-1类药物在该人群中一年内可能实现1-3%的减重。此外，HCQT的获益被描述为令人印象深刻，且与他使用Vykat的经验一致，医生认为这些生活质量终点对PWS患者群体尤为重要。

为此，他希望注册性研究能优先考虑HCQT的获益，尽管对体重和生活质量终点均产生效果是最佳情况（指出Vykat不能改善体重）。在一项评估体重变化的注册性研究中，医生指出大多数患者在20多岁末/30岁出头时体重达到稳定（但仍偏高）水平，并且他预计这些年龄组不会出现显著体重增加（在考虑潜在安慰剂表现时）。

如果获得保险报销，鉴于作用机制不同，医生认为setmelanotide与Vykat的联合使用具有吸引力。

下丘脑性肥胖 (RYTM)

该医生尚未为HO开具Imcivree处方，指出患者每年仅就诊1-2次，但计划近期根据患者的体重/治疗难治性及合并症，让约20%的患者接受治疗。鉴于这是成人团体，医生指出GLP-1类药物的报销相对直接，并且可为部分患者带来高达15%的减重效果。

甲状腺眼病/格雷夫斯病 (VRDN, ROIV/IMVT)

我们简要讨论了格雷夫斯病，医生指出其约25%的患者使用抗甲状腺药物控制不佳，另有部分患者虽得到控制但无法停药，这两类患者都可能成为该适应症中FcRn或IgG降解剂等先进疗法的候选者。他预计这些药物将像目前ATD的实践一样，存在慢性使用和间歇性治疗两种模式。

软骨发育不全 (ASND, BBIO, BMRN, TYRA)

口服药物可能显著扩大软骨发育不全的治疗

该KOL管理着十名儿科ACH患者，包括遗传性和新发病例。其中两名患者目前正在使用Voxzogo。关于迄今为止有限的推广情况，他认为每日注射是儿科护理的巨大负担，并认为每周一次的Yuviwel可能吸引更多患者接受治疗。口服药物（如infigratinib和dabogratinib）推出后将非常适合ACH，并指出部分患者可能正在推迟治疗，等待口服药物上市。

该KOL指出，家庭有时对开始新药物治疗犹豫不决，但认为在其管理的10名患者中，将有3名接受infigratinib治疗，而接受注射治疗的患者为3-4名。

■ FGFR3生物学：该KOL关注与FGFR效应相关的高磷血症。尽管如此，他认为这是可控的，总体上不会成为接受治疗的临床障碍。虽然为时尚早，但该KOL认为，鉴于dabogratinib对FGFR3具有更高的选择性，在关键性研究中其效果可能与infigratinib相当或略优。

肢端肥大症 (CRNX)

10%患者使用Palsonify，但半数可能符合条件；空腹要求管理具有挑战性

\- 我们的专家正在治疗约20-25名肢端肥大症患者，其中2-3名患者使用了Palsonify。使用有限的原因包括：获批时间短、由于Palsonify标价高，支付方要求通过2-3种药物进行阶梯治疗，以及自2020年起口服Mycapssa已可用。该专家的诊所设有专门的垂体中心，因此他能够治疗更多肢端肥大症患者。与CAH相比，肢端肥大症有许多有效的治疗选择。

\- Palsonify要求服药后禁食1小时，这有些问题，因为许多患者接受过经蝶窦切除术，其中80%的患者存在甲状腺功能减退，需要服用同样有禁食要求的Synthroid。这些治疗带来的各种禁食要求对患者来说管理起来具有挑战性。然而，专家未来将增加使用，他的10名患者可能符合Palsonify的使用条件。